

1.- DEPRESIÓN

OAusente: forma y conducta normal en la entrevista. No se aprecia estado depresivo.

OLeve: aunque puede existir alguna evidencia de depresión (tristeza ocasional, falta de energía), el evaluador no lo considera como patológico, o lo toma como un rasgo habitual que no llega a constituir una depresión clínicamente significativa.

OModerada: se piensa que el paciente está clínicamente deprimido, pero en un grado ligero; o sentimientos ocasionales que causan malestar significativo o son vistos por el paciente como algo significativamente diferente de su forma usual de ser en la última semana.

OMarcada: el paciente es visto como clínicamente deprimido en un grado marcado; o sentimientos frecuentes de depresión como los descritos en el punto anterior durante la última semana; u ocasionalmente nivel de extremo malestar ocasionado por la depresión.

OGrave: el paciente es visto como clínicamente deprimido en un grado extremo, el fenómeno depresivo mayor debe estar presente (ideas suicidas fuertemente mantenidas, llanto incontrolable, etc.); o la depresión ha causado un malestar extremo y frecuente en la última semana.

2.- ANSIEDAD

OAusente: humor normal durante la entrevista.

OLeve: se piensa que la tensión que manifiesta el paciente es un rasgo habitual que no alcanza proporciones patológicas, o una respuesta razonable a la situación de la entrevista

OModerada: se piensa que el paciente exhibe un grado leve de ansiedad o tensión clínicamente significativas; o ansiedad suficiente para causar malestar significativo que ha ocurrido ocasionalmente durante la última semana.

OMarcada: el paciente exhibe un grado marcado de ansiedad o tensión clínicamente significativas, puede estar aprensivo acerca de la entrevista y necesita ser tranquilizado en este sentido, pero existen sólo interrupciones menores de la entrevista debido a la ansiedad, puede estar asociada a agitación motriz de grado leve; o ansiedad suficiente para causar malestar significativo que ha ocurrido frecuentemente durante la última semana, o la ansiedad ha causado ocasionalmente malestar extremo para el individuo en la última semana.

OGrave: el paciente exhibe un grado extremo de ansiedad o tensión clínicamente significativa, puede ser incapaz de relajarse o pueden existir interrupciones importantes durante la entrevista debidas a la ansiedad, puede estar asociada a agitación motora de grado marcado o a una preocupación temerosa con acontecimientos amenazantes; o la ansiedad ha causado un malestar extremo para el individuo de forma frecuente en la última semana.

3.- AFECTIVIDAD APLANADA. AFECTIVIDAD INCONGRUENTE.

OAusente: humor normal durante la entrevista.

OLeve: el paciente puede ser lacónico, taciturno o sin respuestas cuando discute temas con carga emocional, pero el entrevistador considera que esto es un rasgo habitual más que un signo de enfermedad, o de dudosa significación patológica.

OModerada: deterioro clínicamente significativo de la respuesta emocional en grado ligero, ocasionalmente existe una clara falta de tono emocional cuando discute temas importantes, pero, sin ninguna duda, existen respuestas emocionales incongruentes durante la entrevista.

OMarcada: deterioro clínicamente significativo de la respuesta emocional en grado marcado, no muestra calidez o afectación, no puede comunicar el impacto de los acontecimientos cuando comenta los hechos, no expresa interés sobre el futuro, o respuestas incongruentes frecuentes de grado ligero, o alguna incongruencia grave de forma ocasional

OGrave: grados extremos de deterioro clínicamente significativo de la respuesta emocional o la incongruencia grave es frecuente (es fatuo, arrogante, ríe tontamente, etc.) de tal forma que perturba la entrevista.

Identificación **Fecha** 2/3

4.- RETRASO PSICOMOTOR

OAusente: habla y se comporta normal durante la entrevista. Las preguntas son respondidas completamente, sin latencia de respuesta, aire espontáneo y cambios de la expresión.

OLeve: aunque puede existir evidencia de lentitud o espontaneidad pobre, el entrevistador considera que esto es, o bien un rasgo habitual o que no alcanza proporciones claramente patológicas.

OModerado: el entrevistador detecta lentitud o falta de espontaneidad en la entrevista y lo atribuye a enfermedad psiquiátrica; es, por tanto, clínicamente detectable. El retardo en las respuestas puede merecer este nivel de evaluación siempre que el entrevistador considere que es parte de un estado mental enfermizo, más bien que de un rasgo habitual del paciente.

OMarcado: retardo psicomotor atribuible a enfermedad psiquiátrica, que es fácilmente detectable en la entrevista y se piensa que hace una contribución material a las anormalidades del estado mental actual del paciente.

OSevero: el retardo psicomotor está presente en grado extremo.

5.- DELIRIOS EXPRESADOS COHERENTEMENTE

OAusentes: no se detecta anormalidad durante la entrevista.

OLeves: creencias excéntricas y errores triviales de interpretación(por ej.: que el mal tiempo está provocado por pruebas nucleares, supersticiones, sectas religiosas, etc.).

OModerados: ideas sobrevaloradas e ideas de referencia, o indudables falsas interpretaciones. Encuentra significados especiales.

OMarcados: verdaderas ideas delirantes o percepciones delirantes han ocurrido en el último mes, pero el paciente niega que existan en la actualidad, pero no son fuertemente mantenidas o incorregibles.

OSeveros: verdaderos delirios están presentes y son aún mantenidos por el paciente.

6.- ALUCINACIONES

OAusentes: no hay evidencia de alucinaciones.

OLeves: las experiencias alucinatorias informadas al entrevistador no son definitivamente enfermizas, alucinaciones hipnagógicas, imágenes eidéticas e ilusiones.

OModeradas: pseudo-alucinaciones auditivas y visuales; alucinaciones asociadas con insight, por ejemplo, aquellas que siguen a una pérdida.

OMarcadas: verdaderas alucinaciones han estado presentes en la última semana, pero han ocurrido infrecuentemente.

OSeveras: verdaderas alucinaciones han ocurrido frecuentemente en la última semana.

Identificación **Fecha** 3/3

7.- INCOHERENCIA E IRRELEVANCIA DEL LENGUAJE

OAusente: no existe evidencia de trastorno del pensamiento.

OLeve: aunque las respuestas son a veces raras, las anormalidades no cumplen criterios para trastorno del pensamiento; siempre es posible conocer la conexión entre las ideas.

OModerada: evidencia ocasional de trastorno del pensamiento, pero el paciente es, fuera de ello, coherente.

OMarcada: evidencia frecuente de trastorno del pensamiento, pero es posible una comunicación significativa con el paciente. O suceden varios episodios de lenguaje incoherente.

OSevera: las respuestas son difíciles de seguir a causa de la falta de línea directriz en las asociaciones. Lenguaje frecuentemente incoherente, sin un percible ensartamiento de significados.

8.- POBREZA DEL LENGUAJE, MUTISMO

OAusente: lenguaje normal en cantidad y en la forma.

OLeve: el paciente sólo habla cuando es preguntado; tiende a dar respuestas breves.

OModerada: dificultades o silencios ocasionales, pero la mayor parte de la entrevista transcurre fácilmente; o la conversación es obstaculizada por vaguedad, vacilación o brevedad de las respuestas.

OMarcada: respuestas monosilábicas; pausas prolongadas frecuentes o fracaso en toda contestación, o razonable cantidad de lenguaje, pero las respuestas son lentas y vacilantes, faltando contenido, o repeticiones y divagaciones, tal que una conversación significativa es casi imposible.

OSevera: mutismo en toda la entrevista, o habla sólo dos o tres palabras, o musita constantemente en voz baja.

TOTAL: